

ADVOCACIA · DIREITO DO PACIENTE E PLANOS DE SAÚDE

Quando o plano nega, a lei protege você

O guia dos seus direitos no plano de saúde — da negativa de cirurgia ao reembolso, do autismo aos medicamentos de alto custo. O que fazer, passo a passo.



Dr. Denis Carvalho

Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

APRESENTAÇÃO

Uma carta para quem precisa do plano e foi surpreendido

Poucas situações são tão angustiantes quanto adoecer — ou ver alguém que amamos adoecer — e descobrir que o plano de saúde, pago em dia, **negou** justamente o tratamento indicado pelo médico. A recusa chega num dos piores momentos, quando falta energia para enfrentar operadora e burocracia.

Reúno **mais de 20 anos de vivência na área hospitalar e mais de 15 anos de atuação jurídica**. Essa combinação me permite enxergar o seu caso pela ótica de quem conhece a saúde por dentro e, ao mesmo tempo, o Direito.

Este guia foi escrito para **descomplicar**. Nele você encontra, em linguagem clara, as negativas mais comuns, o que a lei diz sobre cada uma e o que fazer na prática — além de como a assessoria jurídica pode ajudar a garantir o tratamento que você tem direito.

Não substitui a análise de um caso concreto, mas é um ponto de partida seguro. Boa leitura.



Dr. Denis Carvalho

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde

NESTE GUIA

Sumário

PARTE 1 — SEUS DIREITOS NO PLANO DE SAÚDE

01	O plano negou? A recusa nem sempre é a palavra final	Negativa de Cobertura
02	Rol da ANS: taxativo ou exemplificativo?	Rol da ANS
03	Autismo (TEA): a cobertura das terapias	TEA / Autismo
04	Medicamentos de alto custo: plano e poder público	Medicamentos
05	Reembolso e reajuste: quando contestar	Reembolso e Reajuste
06	Carência, doença preexistente e urgência	Carência e Urgência
07	Home care e tratamentos contínuos	Home Care

PARTE 2 — COMO A ASSESSORIA JURÍDICA ATUA

- Como preparamos o seu caso e como atuamos contra a operadora
- Checklist: o que reunir antes de contestar
- Perguntas frequentes · Sobre o Dr. Denis · Contato

A smiling man with short dark hair, wearing a light gray sweater, is seated in a dental chair. The background is a clinical setting with dental equipment, including a microscope and a computer monitor. The image has a blue overlay.

PARTE 1

Seus direitos **no plano de saúde**

As sete negativas que mais tiram o sono dos beneficiários — e o que você precisa saber sobre cada uma.

01 O plano negou? A recusa nem sempre é a palavra final



O problema. Cirurgias, exames, terapias e internações negados pela operadora estão entre as maiores angústias do paciente — muitas vezes contrariando a indicação do médico que acompanha o caso.

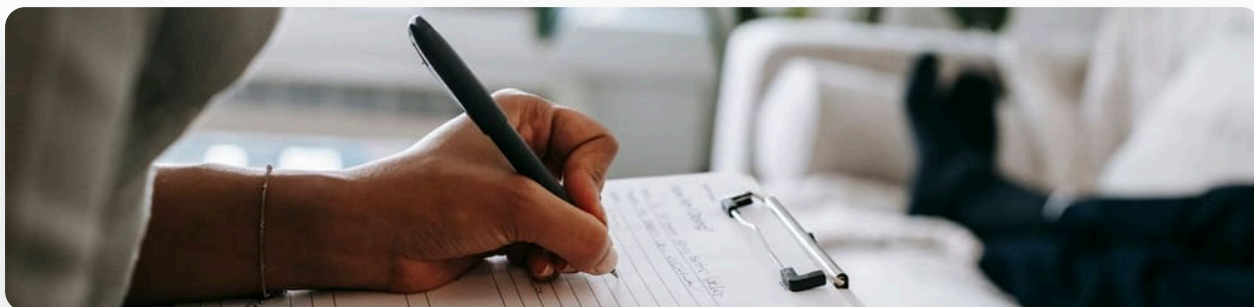
O que diz a lei. A relação é regida pela **Lei nº 9.656/1998** e pelo **Código de Defesa do Consumidor** (Súmula 608 do STJ). Quem define o tratamento adequado é o **médico assistente**; negativas baseadas apenas em "não consta no rol" ou em "caráter experimental" costumam ser questionáveis.



NA PRÁTICA

Exija a negativa **por escrito**, com protocolo, e guarde o relatório médico e os comprovantes. Havendo urgência e risco, pode caber um pedido de **tutela de urgência (liminar)**.

02 Rol da ANS: taxativo ou exemplificativo?



O problema. Muitas recusas se apoiam na frase "não está no rol da ANS". Mas essa afirmação, sozinha, nem sempre encerra a discussão.

O que diz a lei. A **Lei nº 14.454/2022** trouxe critérios para a cobertura de tratamentos **fora do rol**: quando há comprovação de eficácia à luz das evidências científicas, ou recomendação de órgãos técnicos de referência. O rol é o piso obrigatório — não necessariamente o teto.



NA PRÁTICA

Reúna a prescrição médica detalhada e, quando existirem, estudos e pareceres que respaldem o tratamento. É isso que costuma ser decisivo diante de uma negativa "pelo rol".

03 Autismo (TEA): a cobertura das terapias



O problema. Famílias de pessoas com TEA enfrentam, além do diagnóstico, a limitação ou negativa das terapias — ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.

O que diz a lei. Quando a equipe que acompanha o paciente indica determinada terapia, método e frequência como necessários, a imposição de um **teto genérico de sessões** pela operadora tende a ser questionada. A prescrição é decisão clínica, não administrativa.



NA PRÁTICA

Guarde o laudo (com o CID), o relatório da equipe com método e frequência e a negativa por escrito. Não interrompa o tratamento por falta de cobertura sem antes buscar orientação.

04 Medicamentos de alto custo: plano e poder público



O problema. Medicamentos caros — oncológicos, para doenças raras, de uso contínuo — são frequentemente negados, deixando o paciente sem a continuidade do tratamento.

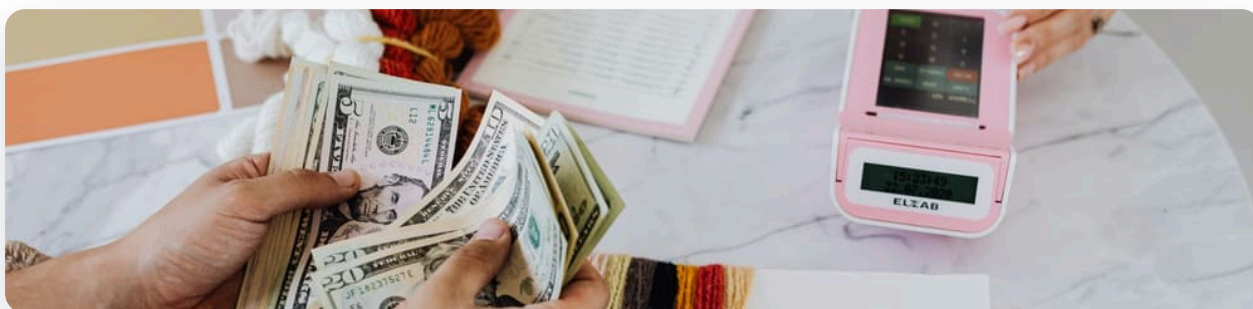
O que diz a lei. A depender do caso, o fornecimento pode ser buscado junto ao **plano de saúde** (havendo cobertura contratual e indicação médica) ou ao **poder público (SUS)**. O registro na Anvisa e a indicação do médico assistente são elementos centrais.



NA PRÁTICA

Reúna a prescrição, o laudo, a negativa por escrito e, se possível, a bula/registo do medicamento. Em casos urgentes, a via judicial com liminar pode garantir o acesso enquanto o processo tramita.

05 Reembolso e reajuste: quando contestar



O problema. Reembolsos negados ou pagos a menor e reajustes que fogem do razoável — por faixa etária ou por sinistralidade — pesam no bolso do beneficiário.

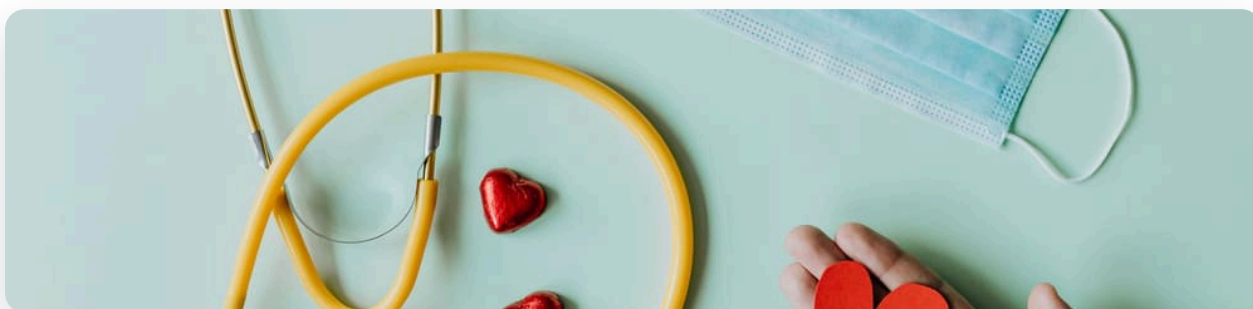
O que diz a lei. O CDC e a Lei nº 9.656/1998 vedam práticas abusivas. Reajustes por mudança de faixa etária e por sinistralidade (planos coletivos) precisam ser **transparentes e demonstrados**; aumentos desproporcionais podem ser revistos.



NA PRÁTICA

Guarde os boletos, o histórico de reajustes e a memória de cálculo que a operadora é obrigada a fornecer. Para reembolso, exija a justificativa formal e os comprovantes das despesas.

06 Carência, doença preexistente e urgência



O problema. Negativas por "carência" ou "doença preexistente" surpreendem muitos beneficiários — especialmente em situações de urgência e emergência.

O que diz a lei. A **Lei nº 9.656/1998** fixa prazos máximos de carência e, em **urgência e emergência**, prevê atendimento após prazo reduzido. Restrições por doença preexistente seguem a Cobertura Parcial Temporária (CPT) e não podem ser presumidas sem o devido processo.



NA PRÁTICA

Em urgência, exija o atendimento e a negativa por escrito. Guarde o contrato, a declaração de saúde e os protocolos — eles definem o que pode (ou não) ser exigido do plano.

07 Home care e tratamentos contínuos



O problema. A negativa de home care, internação domiciliar ou de terapias contínuas interrompe cuidados essenciais e expõe o paciente a riscos.

O que diz a lei. Quando o home care substitui a internação hospitalar e é indicado pelo médico assistente como necessário, a negativa costuma ser questionável — a lógica é a **continuidade do cuidado** e a proteção à saúde do beneficiário.



NA PRÁTICA

Reúna o relatório médico que justifica o home care (equipe, equipamentos e frequência) e a negativa por escrito. A interrupção de um tratamento em curso costuma fundamentar um pedido de urgência.

A background image showing two people in business attire shaking hands over a desk. On the desk, there is a laptop and some papers. The image has a blue tint.

PARTE 2

Como a **assessoria jurídica** atua

Da preparação cuidadosa do caso à ação técnica contra a operadora quando a negativa persiste.

Preparar: organizar o caso antes de agir

Grande parte do resultado se decide antes de qualquer ação: entender o seu contrato, reunir as provas certas e escolher o caminho mais rápido. É esse trabalho cuidadoso que dá força ao seu pedido.

Análise do seu plano

Leitura do contrato e das regras de cobertura, carência e reembolso para você saber exatamente quais são os seus direitos.

Organização das provas

Orientação sobre os documentos que fazem diferença: negativa por escrito, relatórios médicos e comprovantes.

Caminho extrajudicial

Quando possível, a solução direto com a operadora ou pela ANS, de forma mais rápida e menos desgastante.

Clareza sobre os riscos

Uma avaliação honesta da viabilidade do caso, sem promessas — para você decidir com segurança.

Agir: garantir o tratamento quando a negativa persiste

Quando a operadora não recua, cada passo conta. A atuação é técnica, estratégica e transparente — com pedido de urgência (liminar) quando há risco à saúde e acompanhamento em todas as instâncias.

Ações contra operadoras

Negativas de cirurgias, terapias, exames e medicamentos, com pedido de liminar quando há urgência.

Reembolso e reajustes

Cobrança de reembolsos devidos e revisão de reajustes abusivos por faixa etária ou sinistralidade.

Danos morais

Reparação pelos transtornos causados por recusas indevidas, quando cabível no caso concreto.

Acompanhamento integral

Condução do caso em todas as instâncias, com transparência sobre cada etapa.

1

Contato

Você relata o caso com sigilo total.

2

Análise

Avaliamos documentos e viabilidade.

3

Estratégia

Definimos o melhor caminho.

4

Acompanhamento

Você é atualizado em cada etapa.

ANTES DE CONTESTAR

Você já tem tudo o que precisa em mãos?

Marque o que você já reuniu. Cada "não" é um documento a buscar — e são justamente eles que dão força ao seu pedido contra a operadora.

- ☐ Você tem a negativa do plano por escrito, com número de protocolo?
- ☐ Guardou o relatório e a prescrição detalhada do médico assistente?
- ☐ Reuniu exames, laudos e a carteirinha do plano?
- ☐ Está com os comprovantes de pagamento das mensalidades em dia?
- ☐ Registrou os protocolos de todos os contatos com a operadora?
- ☐ Em caso de urgência, exigiu o atendimento e a recusa por escrito?
- ☐ Antes de desistir de um tratamento negado, buscou orientação jurídica?

Ficou algum item em aberto? Não se preocupe: a orientação jurídica ajuda você a reunir e organizar tudo o que for necessário.

Perguntas que recebo todos os dias

- **O plano negou meu tratamento. O que faço primeiro?**

Exija a negativa por escrito (com protocolo) e reúna o relatório médico e os comprovantes. A partir disso é possível avaliar os caminhos — inclusive um pedido de urgência (liminar) quando houver risco.

- **Quanto tempo demora uma liminar?**

Varia conforme o caso e a comarca, mas pedidos de urgência são analisados com prioridade — em situações graves, a decisão pode sair em poucas horas ou dias. Não há garantia de resultado.

- **"Não está no rol da ANS" encerra a discussão?**

Nem sempre. A Lei 14.454/2022 admite a cobertura de tratamentos fora do rol quando preenchidos critérios técnicos. A prescrição médica bem fundamentada costuma ser decisiva.

- **O plano é obrigado a cobrir as terapias do TEA?**

A limitação arbitrária de sessões indicadas pela equipe costuma ser questionável. O que importa é a prescrição clínica (método e frequência) devidamente documentada.

- **Posso pedir o reembolso do que paguei?**

Em muitos casos, sim. Guarde todas as notas e comprovantes e exija a justificativa formal da operadora sobre o valor reembolsado.

Perguntas que recebo todos os dias

- **Um reajuste muito alto pode ser contestado?**

Reajustes por faixa etária ou por sinistralidade precisam ser transparentes e demonstrados. Aumentos desproporcionais podem ser revistos.

- **Você atende em todo o Brasil ou só em Goiás?**

O atendimento é on-line e alcança todo o Brasil, com a mesma proximidade e o mesmo sigilo de um atendimento presencial.

- **Como funciona a primeira conversa?**

É uma análise inicial, sem compromisso, para entender o caso e indicar com clareza os caminhos possíveis.

- **Como funcionam os honorários?**

São definidos de forma transparente, conforme a complexidade e o tipo de atuação, sempre com contrato e sem promessa de resultado.

- **As informações que eu compartilhar são sigilosas?**

Totalmente. O sigilo profissional é dever legal e ético, reforçado pelas boas práticas de proteção de dados.



SOBRE O AUTOR

Dr. Denis Carvalho

Advogado inscrito na **OAB/GO sob o nº 53.904** e **pós-graduado em Direito Médico**, Denis Carvalho atua de forma dedicada ao universo da saúde — defendendo **pacientes e beneficiários** diante de negativas de planos, além de profissionais e instituições.

Sua trajetória une a vivência de quem conhece a rotina hospitalar por dentro ao rigor técnico do Direito, com um atendimento **humanizado, sigiloso e on-line para todo o Brasil**.

+20

anos na área hospitalar

+15

anos de atuação jurídica

BR

atendimento em todo o país



O plano negou? **Vamos conversar**

Se o seu plano negou um tratamento, não aceite a recusa como palavra final. Uma orientação inicial, sem compromisso, mostra com clareza os caminhos possíveis — inclusive em casos de urgência.

WhatsApp: (62) 99258-6422

E-MAIL

contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

INSTAGRAM

[@deniscarvalho.advogado](https://www.instagram.com/deniscarvalho.advogado)

OAB

GO 53.904 · Direito Médico

SITE

coberturaemsaude.com.br

ATUAÇÃO

On-line, em todo o Brasil

ATENDIMENTO

Sigiloso e sem compromisso



"O seu direito à saúde, defendido com **estratégia e proximidade.**"

coberturaemsaude.com.br

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde · Atuação on-line em todo o Brasil